

RECURSO CÍVEL Nº 5001391-66.2024.4.02.5109/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: ANDRE FERNANDO RAYOL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PERITO NÃO CONSTATOU INCAPACIDADE. SENTENÇA BASEADA NO LAUDO PERICIAL. ENUNCIADO 72/TRRJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE CONTESTEM A HIGIDEZ DO LAUDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, baixem os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 20 de março de 2025.

5001391-66.2024.4.02.5109

510015617563 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5001391-66.2024.4.02.5109/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: ANDRE FERNANDO RAYOL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de restabelecimento de auxílio-doença.

Alega o recorrente (evento 42) que é portador de neoplasia no rim esquerdo, submetido a nefrectomia parcial em maio/2022, em controle oncológico restrito. Diz que o conjunto probatório comprova sua incapacidade, conforme os diversos atestados médicos contemporâneos juntados ao feito, inclusive aguardando a conclusão de exames pré-operatórios para a definição de conduta cirúrgica e data de abordagem do procedimento proposto, devido à CID C34 – neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, conforme consta no Evento 1, ANEXO2, Página 9. Este fato faz com que realize o controle oncológico restrito devido ao nódulo pulmonar. Além disso, apresenta adenoma de adrenal esquerda e cistos hepáticos (Evento 1, ANEXO2, Página 10), agravados com depressão (“quadro descompensado depois de tratamento oncológico, ainda presente com possível metástase” - Evento 1, ANEXO2, Página 28). Aduz que o juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial e requer a reforma da sentença ou a realização de nova perícia.

Pleiteia sustentação oral em modo remoto (evento 52).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

De acordo com o Enunciado 112 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais – FONAJEF, “Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a critério do juiz”, entendimento que também é adotado em sede jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DA INCAPACIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA N. 42 DA TNU. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. A realização de perícia por médico especialista só é necessária em casos especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara, o que não é o caso dos autos. Precedentes da TNU (PEDILEF 200872510048413, 200872510018627, 200872510031462).

(TNU, PEDILEF 200972500044683, Rel. Juiz Fed. Antônio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, j. 29/03/2012).

Vale transcrever, ainda, o **Enunciado nº 20 do FOREJEF**:

Nas hipóteses em que o autor for acometido de várias doenças relacionadas a diferentes especialidades médicas, é válida a realização da perícia por médico do trabalho."

Ademais, insta salientar que a perícia é realizada às expensas da Justiça Federal, cujo orçamento está cada vez menor, o que autoriza o juiz a ser mais rigoroso. A propósito, a Lei nº 13.876/19 é expressa no sentido de que, a partir de 2020, será garantido o pagamento de honorários periciais referentes a apenas uma perícia médica por processo judicial.

Por conseguinte, descabe a realização de nova prova pericial, mesmo porque os esclarecimentos técnicos ofertados já se mostram suficientes para auxiliar na compreensão dos fatos essenciais ao exame da causa.

Passo ao mérito.

Importante mencionar a **Súmula 77/TNU**:

O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

Pois bem, a sentença combatida acolheu os fundamentos técnicos acerca do estado de saúde e da possibilidade laboral da parte autora, exarados no laudo médico-pericial juntado aos autos. Tal documento é elaborado por profissional técnico (médico) imparcial, nomeado pelo juízo e equidistante das partes.

A perícia judicial foi feita em **30/10/2024** (evento 26), por **médico do trabalho**, que após exame físico, anamnese e análise dos documentos médicos juntados aos autos atestou que o autor, 51 anos, técnico em segurança do trabalho, é portador de F41 - Outros transtornos ansiosos, C64 - Neoplasia maligna do rim, Z98 - Outros estados pós-cirúrgicos, M50 - Transtornos dos discos cervicais e I10 - Hipertensão essencial (primária), mas **não está incapacitado para o trabalho atualmente**:

Motivo alegado da incapacidade: *Sequelas de Ca e Depressão*

Histórico/anamnese: *Questionado sobre a sua queixa principal o autor alegou ser portador de lesão na sua coluna vertebral, ansiedade e sequela de CA, que lhe provocariam dores generalizadas, edemas, cólicas abdominais, limitações dos movimentos e dificuldade para permanecer na mesma postura por períodos mais prolongados. Alega alta do INSS em 17/10/2024. Alega nefrectomia parcial (e) em 05/2022.*

Alega tabagismo. Nega etilismo e uso de outras substâncias tóxicas.

Relata estar em suspeita de câncer pulmonar.

Observações sobre o tratamento: *Em tratamento conservador (sic), porém ainda tabagista e não comprova tratamento contínuo para sua mazela emocional citada na inicial.*

Conclusão: sem incapacidade atual

- Justificativa: Após avaliação médica pericial, que contou com a elaboração de exame clínico, assim como de documentos relacionados ao seu histórico patológico pregresso, não identifiquei a presença de distúrbios, lesões ou sequelas com manifestações incapacitantes para o trabalho. Devemos esclarecer as partes que o fato de o segurado portar patologia não significa necessariamente a existência de incapacidade, e que, a Lei de regência do benefício fixa que este pressupõe a incapacidade, e não apenas a existência de patologia.

No mesmo sentido, no exame feito administrativamente em **17/09/2024** (evento 11 - out 2), o médico perito do INSS considerou a parte autora capaz para as atividades habituais:

HISTÓRICO: perícia médica resolutive (aps volta redonda) -benefício cessado em 06/2023 e reativado judicialmente. requerente retorna nesta data informando que irá fazer biopsia nódulo pulmonar. refere também ansiedade e depressão. apresenta laudo dr. guilherme menezes, oncologista, de 11/09/2024, informando cid c64, i10 e f41. laudo dr anderson tavares, urologista, sem data, informando carcinoma renal papilífero submetido a nefrectomia parcial, no momento com exames de imagem sem evidências de recidiva da doença. laudo dra katia froes, psiquiatra, de 17/07/2024, informando cid f32. tc torax 26/04/2024: nódulo no lobo medio pulmonar estavel evolutivamente em relação ao exame anterior, configurando aspecto fibrocicatricial.tc abdome total 26/04/2024: cistos hepaticos adenoma adrenal esquerdo, nefrectomia parcial a esquerda, cistos renais, nefrolitíase a esquerda. receitaário: sertralina, quetiapina, corus, hctz, anlodipina, espirolactona, sinvastatina.

EXAME FÍSICO: lucido, orientado, eupneico em repouso, cooperativo, respondendo bem as solicitações verbais. bom estado geral. mucosas coradas, hidratadas e anictéricas. aparelho respiratório: pulmões limpos sem ruídos adventícios bilateralmente. ritmo cardíaco regular dois tempos, bulhas normofonéticas sem sopros ou extra-sístoles. presença de cicatriz cirúrgica localizada na região de flanco esquerdo, bem constituída, sem sinais de flogose.

CONSIDERAÇÕES: considerando os achados do exame físico e as documentações apresentadas, não foi comprovado no momento deste ato pericial, alterações incapacitantes que justifiquem a prorrogação do benefício ou que contraindique a manutenção do tratamento ambulatorial concomitante com o exercício de suas atividades laborativas.

RESULTADO: não existe incapacidade laborativa.

Ressalto que os documentos, atestados e laudos trazidos com a inicial não possuem considerações técnicas superiores àquelas lançadas no laudo pericial e não são suficientes para alterar a conclusão do perito, até porque foram devidamente analisados quando do exame. O laudo está devidamente fundamentado e sem qualquer omissão ou contradição a ponto de impedir a valoração judicial para a solução da controvérsia, sendo que o perito, ao exarar seu parecer conclusivo, analisou e levou em conta toda a documentação médica juntada aos autos.

Vale lembrar que receitaários não significam que o simples uso de medicamentos impeça a parte de trabalhar e exames são documentos que não mencionam condições pormenorizadas sobre o impacto da doença na rotina laboral do segurado.

A prova pericial objetiva proporcionar ao juiz os conhecimentos técnicos de sua área que nem juízes e advogados possuem. Somente pode ser afastada caso existam nos autos outros documentos médicos com fortes provas e conclusões superiores àquelas do perito judicial e do INSS. O fato de haver divergência entre as conclusões do perito médico judicial, que, aliás, foram as mesmas do perito médico do INSS, e as eventuais manifestações do médico do segurado, por si só, não compromete a eficácia do laudo produzido em Juízo. Afinal, não se pode perder de perspectiva que, em ações cujo cerne é a incapacidade/capacidade laboral, sempre haverá posicionamentos técnicos divergentes.

De fato, a parte autora, a quem o benefício foi negado administrativamente, alega estar incapacitada para o trabalho por estar doente. Por outro lado, a autarquia, ao negar o benefício, alega a inexistência de incapacidade. Aliás, se assim não fosse, não haveria nem mesmo lide, pretensão resistida. Por conseguinte, para a solução da mesma, mostra-se necessária a realização de perícia médica por *expert* imparcial, nomeado pelo juízo, cujo laudo, obviamente, será contrário às manifestações dos médicos de pelo menos uma das partes.

Cabe lembrar que a Resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina) nº 18551/2008 trata da **caracterização de incapacidade laborativa como prerrogativa dos médicos peritos**. Ao médico assistente é dado PRESUMIR a incapacidade de seu cliente. Porém, cabe ao médico perito ATESTAR a capacidade ou incapacidade do examinado para que produza efeitos legais.

Para maior esclarecimento, trago à colação a explicação do perito médico Dr. Alberto Estevez Garcia:

Adredemente, temos que afirmar ao julgador, que MÉDICO PERITO, NÃO É PERITO MÉDICO. O médico que consulta e trata os paciente, mantém um relacionamento de confiança com seus pacientes e este com ele. Ouve com credulidade suas queixas reais e fictícias, acredita nelas, conforta e medica fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Por sua vez, o paciente confia no médico assistencialista e este passa a ser sua âncora, bengala, ao qual faz confidências com certeza do segredo guardado pelo sigilo profissional.

A estes, denominamos de MÉDICO PERITO.

Já o PERITO MÉDICO, não guarda relação com o periciado, apenas o pericia em determinado momento, não guarda qualquer relação com o autor, procura sempre correlacionar, o tipo de enfermidade com sua atividade profissional, daí a importância crucial de ser médico do trabalho e conhecer de profissiografia para a conclusão de capacidade laboral ou incapacidade.

Para concessão de benefício por incapacidade temporária ou permanente, impõe-se comprovação de incapacidade do segurado para suas atividades habituais, temporária ou definitivamente. Importa ressaltar que o simples fato de o segurado do INSS ser portador de determinada doença, sob controle e acompanhamento médico, medicamentoso, fisioterápico e/ou psicoterapêutico, não implica, por si só, no reconhecimento de efetiva incapacidade para o trabalho. De fato, diversas são as doenças de fundo que acometem milhões de indivíduos, mas cujos sintomas e evolução admitem efetivo controle mediante regular acompanhamento e/ou tratamento médico, sem que gerem incapacidade funcional para o trabalho.

De se acrescentar que, se o requisito da incapacidade não está preenchido, outros fatores e aspectos sociais não podem ensejar sozinhos a concessão pretendida. Nesse sentido, transcrevo a Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização: *"O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual"*.

Por fim, cabe a aplicação do Enunciado 72 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que dispõe: *"Não merece reforma a sentença que acolhe os fundamentos técnicos do laudo pericial para conceder ou negar benefício previdenciário ou assistencial quando o recurso não trazer razões que possam afastar a higidez do laudo"*.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, *in fine*, do Código de Processo Civil, suspenso em caso de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO**. Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, baixem os autos.